



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
TIM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
RS PRIMA HUSADA**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat Nya Pedoman Kerja Tim Penanggulangan tuberkulosis dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakannya Pedoman Kerja Tim Penanggulangan tuberkulosis ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik. Akhir kata, kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.

LEMBAR PENGESAHAN

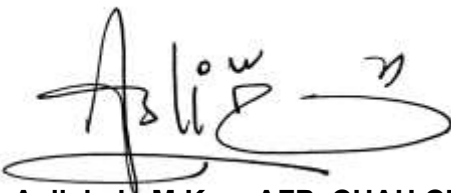
Pedoman Kerja Tim Penanggulangan Tuberkolosis
Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Tahun 2026

Penanggung Jawab :



(Citra Intan Pratiwi, S.Kep., Ns)

Disetujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kep.,AFP.,CHAH,CHQP)

Ditetapkan Oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep)

TIM PENYUSUN

PENGARAH :

1. Dr.dr. Aslichah, M.Kep.,AFP
2. Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

PENYUSUN :

1. dr. Novita Maulidya Sp.P
2. Citra Intan Pratiwi S.Kep.,Ns

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

TM PENYUSUN..... iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

PERATURAN DIREKTUR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 2

BAB II PENGORGANISASIAN..... 3

 2.1 Susunan Tim Penanggulangan Tuberkulosis 3

 2.2 Uraian Tugas dan Wewenang 3

 2.3 Tata Hubungan Kerja..... 4

BAB III RUANG LINGKUP PEDOMAN KERJA TIM 5

 3.1 Ruang Lingkup Kegiatan 5

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 9

 4.1 Monitoring 9

 4.2 Evaluasi 9

 4.3 Pelaporan..... 9

BAB V PENUTUP 10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Struktur Tim Penanggulangan Tuberkulosis 3



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 004.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2026**

**TENTANG
PEDOMAN KERJA TIM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan;

b. bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memiliki peran strategis dalam penemuan kasus, penegakan diagnosis, tata laksana, pelaporan, serta pencegahan dan pengendalian infeksi Tuberkulosis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Kerja Tim Penanggulangan Tuberkulosis.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

4. PP 28 th 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan UU no 17 tahun 2023

5. Perpres No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

6. Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

7. KMK No.HK.01.07-MENKES-350-2017 tth RS dan Balai Kesehatan Layanan Tuberkulosis Resisten Obat;

8. PMK No.27 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes;

9. Kepdirjen Nomor Hk.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman survei Akreditasi Rumah Sakit;

10. Kepdirjen Nomor HK.01.07./MENKES/1596/.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;

11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN KERJA TIM PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
- (2) Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis;
- (3) Tim Tuberkulosis adalah suatu tim multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin untuk menangani masalah Kesehatan prinsip tata kelola pelayanan terpadu dan paripurna dengan mendekatkan pelayanan kepada pasien tuberkulosis.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2 Pembentukan Tim Penanggulangan Tuberkolosis

- (1) Direktur rumah sakit menetapkan bentuk organisasi program pelayanan penanggulangan tuberkulosis di Rumah sakit dalam bentuk tim ;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga Kesehatan multidisiplin sesuai kebutuhan;
- (3) Direktur Rumah Sakit menetapkan ketua tim penanggulangan tuberkulosis adalah dokter spesialis paru ;
- (4) Anggota tim pelayanan penanggulangan tuberkulosis terdiri dari :
 - a. Perawat poli paru ;
 - b. Perawat Irna ;
 - c. Perawat IGD;
 - d. Laboratorium;
 - e. Farmasi.
 - f. PKRS

BAB III TATA LAKSANA

Pasal 3 Ruang Lingkup Kegiatan

- (1) Tim penanggulangan tuberkulosis Rumah Sakit melaksanakan kegiatan penanggulangan TB secara terkoordinasi, terintegrasi,



dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pelaksanaan kegiatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, serta pencatatan dan pelaporan kasus TB.

Pasal 4

Penemuan dan Diagnosis Kasus

- (1) Tim melaksanakan penemuan dan penegakan diagnosis TB sesuai standar;
- (2) Setiap pasien dengan dugaan TB wajib dilakukan pemeriksaan sesuai algoritma diagnosis yang berlaku;
- (3) Tim memastikan tersedianya akses pemeriksaan penunjang yang diperlukan, termasuk pemeriksaan bakteriologis dan radiologis.

Pasal 5

Tata Laksana Pengobatan

- (1) Tim memastikan seluruh pasien TB mendapatkan tata laksana pengobatan sesuai standar terapi nasional;
- (2) Tim melakukan pemantauan kepatuhan minum obat dan keberhasilan terapi sampai dinyatakan sembuh atau menyelesaikan pengobatan;
- (3) Dalam hal ditemukan kasus TB resistan obat, tim berkoordinasi dengan fasilitas rujukan yang ditetapkan.
- (4) Pemberian obat pencegahan ditujukan kepada kontak dengan pasien TBC, orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV/ Acquired Immuno Deficiency Sndrome (AIDS) yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.

Pasal 6

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

- (1) Tim bekerja sama dengan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dalam menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi TB di lingkungan rumah sakit;
- (2) Setiap unit pelayanan wajib menerapkan kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi airborne terhadap pasien TB;
- (3) Tim melakukan pemantauan kepatuhan penerapan PPI secara berkala.

Pasal 7

Promosi Kesehatan dan Surveilans

- (1) Tim menyelenggarakan edukasi kepada pasien, keluarga, komunitas, masyarakat dan tenaga kesehatan terkait pencegahan, pengobatan, dan pengendalian TB;
- (2) Tim mendukung pelaksanaan surveilans internal dan eksternal dalam rangka pengendalian TB di rumah sakit;
- (3) Tim berperan aktif dalam kegiatan jejaring TB dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain.



BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

- (1) Tim Pelayanan tuberkulosis wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan TBC secara berkala;
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan

Pasal 9 Pencatatan dan Pelaporan

- (1) Seluruh kegiatan pelayanan tuberkulosis dilaporkan melalui laporan bulanan rumah sakit dan pelaporan sistem informasi tuberkulosis ;
- (2) Tim menyusun laporan kegiatan dan capaian indikator mutu secara berkala;
- (3) Laporan disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Rumah Sakit Prima Husada Nomor... tentang Pedoman Kerja Tim Penanggulangan Tuberkulosis sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Januari 2026
Direktur RS Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari,S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR 018.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG PEDOMAN KERJA TIM
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

PEDOMAN KERJA TIM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan dunia. Penyakit ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap angka kesakitan, kematian, serta beban pembiayaan kesehatan. Sebagai negara dengan beban TB yang tinggi, Indonesia terus melakukan penguatan program penanggulangan TB secara komprehensif dan terintegrasi di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka mendukung program nasional penanggulangan TB, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan melalui Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan TB secara menyeluruh termasuk di rumah sakit. Selain itu, standar akreditasi rumah sakit yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) mewajibkan adanya sistem pelayanan yang terintegrasi, termasuk pembentukan tim atau program khusus untuk pengendalian penyakit menular prioritas seperti TB.

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang telah membentuk Tim Penanggulangan Tb yang berperan strategis dalam pengawasan atau pemantauan dan evaluasi program Tb seperti penemuan kasus, penegakan diagnosis, tata laksana pengobatan, penanganan kasus komplikasi, serta pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kasus TB. Selain itu, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab dalam menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) untuk mencegah terjadinya transmisi TB di lingkungan pelayanan kesehatan.

Untuk memastikan pelaksanaan program penanggulangan TB berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai standar, diperlukan suatu Pedoman Kerja Tim Penanggulangan TB di Rumah Sakit. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh anggota tim dan unit terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara sistematis, terukur, dan terdokumentasi.

Dengan tersusunnya pedoman kerja Tim ini, diharapkan upaya penanggulangan TB di rumah sakit dapat berjalan optimal, mendukung pencapaian target nasional eliminasi TB, meningkatkan mutu pelayanan, serta menjamin keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung rumah sakit.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman kerja tim penanggulangan tuberkulosis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi rumah sakit dalam membentuk, mengorganisasikan, dan menyelenggarakan penanggulangan tuberkulosis melalui tim multidisiplin secara terstruktur,



terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan, guna memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien Tuberkulosis, standar pelayanan kesehatan, serta standar akreditasi rumah sakit.

2. Tujuan Umum

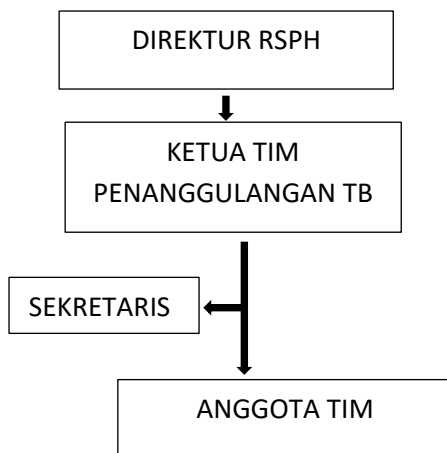
Terselenggaranya tugas-tugas tim penanggulangan tuberkulosis yang komprehensif, terpadu, bermutu, efektif, efisien, dan berorientasi dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3. Tujuan Khusus

- a. Menjadi pedoman kerja dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas tim penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit.
- b. Terlaksananya manajemen pelayanan TB dari aspek administrasi & manajemen, kompetensi SDM, fasilitas dan sarana serta prosedur pelayanan di RS.
- c. Mempermudah koordinasi, monitoring, dan evaluasi program TB.
- d. Menetapkan tata laksana (pemantauan dan evaluasi program), pencatatan, pelaporan, dan tanggung jawab tim.

BAB II PENGORGANISASIAN

2.1 Struktur Tim Penanggulangan Tuberkulosis



Tabel 2.1.1 Struktur Tim Penanggulangan Tuberkulosis

Ketua Tim	:	dr. Novita Maulidiyah, Sp.P
Sekretaris	:	Irawati S.Kep.,Ns
Anggota	:	
1. Apoteker	:	Apt.Rohmah Madya Ayu Fitriana S.Farm
2. Perawat Rawat inap	:	Novita Febri Setiyani S.Kep., Ns
3. Perawat Poli paru	:	Citra Intan Pratiwi S.Kep.,Ns
4. Analis Kesehatan	:	Nikmatul khoriah A.Md.Kes
5. PKRS	:	Novi .,SKM

2.2 Uraian Tugas dan Wewenang

1. Ketua Tim Pelayanan Tuberkulosis

a. Uraian Tugas

- 1) Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu profesi pelayanan;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan maupun kepala instalasi yang terkait dalam membina kualitas profesi pelayanan;
- 3) Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kualitas pelayanan profesi.

b. Wewenang

- 1) Mendelegasikan tugas apabila berhalangan hadir;
- 2) Memeriksa hasil kegiatan Pengendalian Tuberkulosis;
- 3) Dokter Spesialis/ Dokter Umum.

2. Perawat

a. Uraian Tugas

- 1) Melakukan skrining pasien di awal masuk poli paru/ poli anak;
- 2) Melakukan cek penandaan pasien dengan diagnose TB pada RM;
- 3) Melakukan koordinasi dengan tim penanggulangan tuberkulosis dan tim PPI dalam rangka kegiatan operasional;
- 4) Melakukan kegiatan-kegiatan operasional untuk pelayanan Penanggulangan tuberkulosis (pengawasan APD di poli paru/poli anak berupa pemakaian masker baik pasien maupun pengantar);
- 5) Pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan;
- 6) Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Penanggulangan tuberkulosis termasuk pencatatan dan pelaporan.



- b. Wewenang
 - 1) Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai kompetensi;
 - 2) Mengidentifikasi masalah keperawatan;
 - 3) Mengusulkan intervensi kepada tim;
- 3. Apoteker
 - a. Uraian Tugas
 - 1) Melaksanakan pelayanan obat untuk penanggulangan tuberkulosis;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan ketua tim penanggulangan tuberkulosis dan tim medis lain;
 - 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus-kasus terkait obat penanggulangan tuberkulosis.
 - b. Wewenang
 - 1) Melakukan review terapi obat;
 - 2) Melakukan perencanaan, pengadaan obat ke Dinas Kesehatan;
 - 3) Memberikan edukasi penggunaan obat.
- 4. Analis kesehatan
 - a. Uraian Tugas
 - 1) Melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium terkait pelayanan penanggulangan tuberkulosis;
 - 2) Melaksanakan pemantauan pelaporan pelayanan penanggulangan tuberkulosis terkait hasil analisa laboratorium;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan ketua tim penanggulangan tuberkulosis terkait dengan pelayanan penanggulangan tuberkulosis.
 - b. Wewenang
 - 1) Memberikan hasil pembacaan hasil TCM;
 - 2) Memberikan edukasi tentang cek dahak.

2.3 Tata Hubungan Kerja

1. Tim bekerja lintas unit, melapor ke Koordinator Program TB dalam hal ini melalui satu pintu;
2. Koordinator Program TB melapor kepada manajemen RS dan Dinas Kesehatan melalui SITB;
3. Setiap unit wajib koordinasi dalam pelaksanaan, pencatatan, dan evaluasi kegiatan.

Tata hubungan kerja ke unit Adalah secara horizontal dalam bentuk koordinasi sedangkan secara vertical garis komando terhadap Direktur RS.

BAB III

Ruang Lingkup Pedoman Kerja Tim Penanggulangan TB

Ruang lingkup pedoman kerja Tim Penanggulangan Tuberkulosis (TB) mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program TB di rumah sakit.

Tim Penanggulangan TB bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan penanggulangan TB berjalan sesuai dengan standar pelayanan, keselamatan pasien, serta ketentuan Permenkes dan akreditasi rumah sakit.



Ruang lingkup kegiatan tim penanggulangan TB meliputi :

3.1 Perencanaan Program TB

- 1) Penyusunan program tahunan TB termasuk penetapan indikator kinerja (CDR, TSR, dll)
- 2) Penyusunan program kerja Tim penanggulangan tahunan TB
- 3) Penyusunan rencana anggaran (RBA)
- 4) Penyusunan TOR kegiatan jika ada kegiatan yang membutuhkan anggaran

3.2 Koordinasi dan Integrasi Program (Rapat)

- 1) Koordinasi lintas unit (pelayanan, laboratorium, farmasi, PPI, promkes)
- 2) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan jejaring TB
- 3) Integrasi program TB dengan program lain (HIV, DM, gizi)

3.3 Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Pelatihan petugas TB (DOTS, SITB, TPT)
- 2) Sosialisasi SOP dan kebijakan TB
- 3) Pembinaan dan supervisi petugas

3.4 Monitoring Program TB

- 1) Pemantauan capaian indikator program TB
- 2) Supervisi pelaksanaan kegiatan di unit pelayanan
- 3) Pengumpulan dan analisis data program

3.5 Evaluasi Program TB

- 1) Audit kasus TB
- 2) Rapat evaluasi berkala (feedback kepada unit terkait)
- 3) Identifikasi masalah dan hambatan (dalam laporan internal)
- 4) Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL dalam laporan internal)

3.6 Pelaporan Program TB

- 1) Pelaporan internal kepada manajemen rumah sakit
- 2) Pelaporan eksternal kepada Dinas Kesehatan melalui SITB
- 3) Penyusunan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan

1.7. Melakukan Pemantauan dan evaluasi MFK-K3

- 1) Melakukan Pemantauan sarana prasarana R. TB sesuai standard
- 2) Melakukan evaluasi sarana prasarana R. TB sesuai standard
- 3) Melakukan pemantauan dan Evaluasi MCU staf area isolasi TBC

3.8 Pengendalian Mutu (PMKP)

- 1) Pemantauan kepatuhan penggunaan APD
- 2) Pemantauan kepatuhan pengisian RM
- 3) Audit kepatuhan PPK-CP

3.9 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TB

- 1) Pemantauan kepatuhan penggunaan APD
- 2) Pemantauan kepatuhan Cuci tangan staf ruangan TBC
- 3) Pemantauan penempatan pasien (R.isolasi pasien TB)
- 4) Pemantauan kebersihan ruangan TB

3.10 Pemantauan Promosi Kesehatan terkait TB

- 1) Pemberian kekebalan dalam rangka Penanggulangan TB dilakukan melalui imunisasi BCG terhadap bayi
- 2) KIE Pasien dan keluarga TB
- 3) KIE pengunjung dan komunitas berbasis RS
- 4) Sosialisasi program TB di lingkungan rumah sakit
- 5) Penyediaan media edukasi
- 6) Pemberdayaan Masyarakat

1.11. Pengelolaan Logistik Program TB

- 1) Pengelolaan Logistik Program TB
- 2) Monitoring ketersediaan obat TB (OAT), TPT, dan vaksin BCG
- 3) Koordinasi dengan instalasi farmasi
- 4) Pengelolaan distribusi logistik TB



BAB III

TATA LAKSANA PEDOMAN KERJA TIM PENANGGULANGAN TB

5.1 Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan TB

Pelaksanaan pelayanan TB dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta terintegrasi dalam Program Nasional TB dan standar akreditasi (Program Nasional, PPI, PAP, PMKP, dan MIRM). Dalam pelaksanaan penanggulangan TB dapat diselenggarakan melalui :

1. Promosi kesehatan;
2. Surveilans TB;
3. Pengendalian faktor resiko;
4. Penemuan dan penanganan kasus TB;
5. Pemberian kekebalan;
6. Pemberian obat pencegahan.



5.2 Pemantauan Dan Evaluasi Promosi Kesehatan Terkait TB

Promosi kesehatan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang TB, meningkatkan kepatuhan pengobatan, dan mencegah penularan di rumah sakit dan masyarakat. Dalam pemberian promosi kesehatan dilakukan oleh semua unit pelayanan dengan :

1. Memberikan edukasi sejak pasien teridentifikasi suspek TB;
2. Memberikan penyuluhan kelompok di ruang tunggu klinik TB, Irna isolasi TB dan yang lain;
3. Menyediakan media KIE (video, poster dan leaflet);
4. Memberikan edukasi massa melalui radio, TV, Medsos

5.3 Surveilans TB

Surveilans dilakukan untuk memantau tren kasus TB dan keberhasilan pengobatan serta mendukung pelaporan nasional. Kegiatan dalam pelaksanaan surveilans TB sebagai berikut :

1. Mencatat semua kasus TB dalam register TB;
2. Pelaporan dilakukan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB);
3. Monitoring dan evaluasi keberhasilan pasien dalam pengobatan TB;

5.4 Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Faktor Resiko (MFK-K3)

- 1) Pemantauan dan evaluasi pengendalian administratif dilakukan dengan melakukan skrining pada pasien batuk, pemisahan pasien suspek TB, dan melakukan triase sesuai SPO TB di IGD termasuk dalam upaya mitigasi risiko;
- 2) Pengendalian lingkungan dalam pelaksanaan pelayanan penanggulangan TB berupa tersedianya ventilasi, hepa mobile, kipas angin, sistim kohorting, yang memadai (alami/mekanik) , menyediakan ruang isolasi TB sesuai jenis kelamin, anak dan dewasa dan mengatur alur pasien TB;
- 3) Pengendalian perilaku yaitu menyediakan masker medis untuk pasien dan pemakaian masker N95 untuk petugas jika melakukan tindakan;
- 4) Melakukan skrining berkala bagi petugas TB dengan MCU 1 tahun 2x.

5.5 Pemantauan Dan Evaluasi Penemuan dan Penanganan Kasus TB

Penemuan kasus TB di Rumah Sakit dilakukan secara pasif dan aktif, terintegrasi di seluruh unit pelayanan (IGD, Rawat Jalan, dan Rawat Inap).

1. Pemantauan dan evaluasi skrining pada kelompok risiko tinggi (pasien dengan suspek TB, kontak erat pasien TB, pasien HIV dan tenaga kesehatan);
2. Pemantauan dan evaluasi pemeriksaan penunjang berupa Tes Cepat Molekuler (TCM) dan foto Thorax;
3. Pemantauan dan evaluasi penanganan kasus TB dilakukan penegakan diagnosis serta Rumah Sakit mampu memberikan pengobatan TB khusus :
 - a. TB Dewasa
 - b. TB anak
 - c. TB ekstra paru
Pemeriksaan yang dipakai untuk menegakkan TB ekstra paru menggunakan TCM yaitu dari cairan serebro spinal, kelenjar limfe dan jaringan).
 - d. TB resisten obat : dilakukan rujukan karena ketidakmampuan pelayanan RS

5.6 Pemantauan Dan Evaluasi Pemberian Kekebalan

Melakukan supervisi dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian imunisasi BCG pada bayi sesuai jadwal nasional pada usia 0–1 bulan atau sebelum bayi berusia 3 bulan.

1. Apakah skrining dilakukan sebelum imunisasi?
 - a. Memastikan bayi dalam kondisi sehat
 - b. Tidak terdapat kontraindikasi imunisasi BCG
 - c. Tidak terdapat tanda/gejala tuberkulosis aktif



2. Apakah KIE orang tua tentang imunisasi telah diberikan dengan materi dibawah ini? ;
 - a. Manfaat imunisasi BCG dalam mencegah TB berat pada anak
 - b. Reaksi yang mungkin timbul pasca imunisasi
 - c. Pentingnya melengkapi imunisasi dasar
 3. Apakah sudah tercatat dalam sistem imunisasi nasional?
- 5.7 Pemantauan Dan Evaluasi Pemberian obat pencegahan
Melakukan supervisi dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) yang ditujukan pada :
- a. anak < 5 tahun dengan kontak TB,
 - b. kontak erat dengan pasien TB,
 - c. rang dengan HIV dan pasien dengan imunokompromasi

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai pelaksanaan tim penanggulangan TB, mengukur capaian indikator, serta memastikan pelayanan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien.

4.1 Monitoring (Pemantauan)

Monitoring atau pemantauan dilakukan anggota Tim TB untuk semua program TB. Pelaporan melalui SITB yang dilakukan setiap hari ketika ada penemuan kasus TB. Sedangkan untuk Pemantauan internal dengan supervisi terpadu dilakukan 1 bulan sekali dan hasilnya dimasukkan dalam bentuk laporan bulanan yang dilaporkan kepada direktur Rumah Sakit Prima Husada.

4.2 Evaluasi

- 1) Evaluasi tata laksana pengobatan
 - a. Kesesuaian regimen dengan pedoman nasional
 - b. Monitoring efek samping
 - c. Kepatuhan pasien minum obat, control, PHBS
 - d. Keberadaan PMO
- 2) Evaluasi PPI TB
 - a. Skrining batuk di pintu masuk (skrining primer) baik di lobby IRJA maupun IGD
 - b. Kepatuhan penggunaan masker
 - c. Ketersediaan ruang isolasi sesuai standard
 - d. Edukasi etika batuk, APD dan Upaya proven
- 3) Evaluasi Mutu TB
- 4) Evaluasi PKRS-TB
- 5) Evaluasi MFK-K3 TB

Evaluasi dilaksanakan dengan membuat laporan sesuai tata naskah yang berisi narasi, tabulasi, grafik jika diperlukan, analisis dan rencana tindak lanjut.

4.3 Pelaporan Internal

- 1) Disampaikan kepada kepala unit TB dan manajemen rumah sakit melalui SIM sekretariat setiap bulan sebelum tanggal 3;
- 2) Meliputi jumlah kasus, kepatuhan pengobatan, cakupan imunisasi, dan pelaksanaan PPI, MFK, Mutu, PKRS TB dan semua Kinerja produktifitas terkait TBC;
- 3) Dilakukan bulanan, triwulan dan tahunan.



4.4 Pelaporan Ekternal

- 1) Disampaikan ke Dinas Kesehatan / SITB sesuai format nasional;
- 2) Meliputi indikator kinerja utama ;
 - a. Case Detection Rate (CDR)
 - b. Treatment Success Rate (TSR)
 - c. Cakupan TPT
 - d. Cakupan imunisasi BCG
 - e. Kelengkapan laporan PPI dan Promkes
 - f. Dilakukan bulanan dan tahunan

BAB V PENUTUP

Pedoman Kerja Tim Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Rumah Sakit ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan, pengendalian, pencatatan, pelaporan, serta evaluasi program TB di rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pedoman Nasional Penanggulangan TB, serta Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS).

Pedoman ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan TB yang komprehensif, terintegrasi, bermutu, dan berkesinambungan, meliputi penemuan kasus, penegakan diagnosis, tatalaksana pengobatan, pencegahan dan pengendalian infeksi, edukasi, serta monitoring dan evaluasi program. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh tenaga kesehatan dan unit terkait di rumah sakit memiliki pemahaman dan langkah kerja yang seragam dalam mendukung Program Nasional Eliminasi Tuberkulosis.

Pelaksanaan pedoman ini memerlukan komitmen bersama dari manajemen rumah sakit, Tim TB, tenaga kesehatan, serta dukungan jejaring eksternal seperti Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Evaluasi dan peninjauan ulang pedoman ini akan dilakukan secara berkala sesuai perkembangan kebijakan nasional, hasil monitoring dan evaluasi program, serta kebutuhan peningkatan mutu pelayanan.

Demikian pedoman kerja ini disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Diharapkan melalui implementasi yang konsisten dan berkesinambungan, rumah sakit dapat berperan aktif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Tuberkulosis serta berkontribusi dalam pencapaian target Eliminasi TB di Indonesia.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Januari 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep